

Bottom-up *gdy myślenie zawodzi*

W wysokiej aktywacji kora przedczołowa jest offline. Techniki oddolne (oddech, głos, ruch, dotyk) działają niezależnie od poznawczej regulacji.

CZAS: codzienna praktyka 10–20 min + interwencja **REALIZACJA:** Faza 1 fundament, ciągła

ŹRÓDŁO: van der Kolk (2014, *The Body Keeps the Score*; 2014 RCT joga); Ogden i in. (2006, *Sensorimotor Psychotherapy*); Porges (2011, teoria poliwalgalna); Levine (2010, *Somatic Experiencing*); Grandin (1992, *deep touch pressure*)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **cztery techniki regulacji** brzusznej gałęzi nerwu błędnego: oddech 4-7-8, „voo”-nucenie, kontakt fizyczny, orientacja Levine. W sekcji 02 — **uzasadnienie neurobiologiczne**: dlaczego ciało jest „wejściem” do regulacji w C-PTSD. Sekcja 03 — **twój zestaw narzędzi** + plan codziennej praktyki.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W C-PTSD regulacja *odgórna* (ang. *top-down*, przez myślenie) **zawodzi w wysokiej aktywacji** — kora przedczołowa jest *offline*. Klientka w panice, której terapeuta mówi „oddychaj głęboko”, próbuje — ale krótkimi, szybkimi oddechami, co **zwiększa** aktywację (hiperwentylacja). Standardowe „oddychaj” bez specyfikacji może pogorszyć stan. Skuteczne są natomiast **techniki oddolne** (ang. *bottom-up*): działają na poziomie nerwu błędnego, niezależnie od woli i myślenia. Bessel van der Kolk (2014, *The Body Keeps the Score*): trauma jest *przechowywana w ciele* — chroniczne napięcie mięśniowe, somatyzacja, bóle, zaburzenia trawienia, osłabiona propriocepcja, odcięcie od ciała. Sama „rozmowa” (odgórna) *nie wystarcza* w C-PTSD — potrzebne jest podejście oddolne. Ogden i in. (2006, 2015, *Sensorimotor Psychotherapy*): praca z ciałem w *oknie tolerancji* — obserwacja i modyfikacja wzorców somatycznych (napięcie, zamrożenie, postawa zapadnięta — ang. *collapsed posture*) bez konieczności werbalizacji treści traumy. Van der Kolk i in. (2014, RCT, N = 64): **trauma-sensitive yoga** przez 10 tygodni istotnie redukuje C-PTSD (d = 0,57 wobec braku poprawy w grupie kontrolnej) — *jedyny* RCT jogi specyficznie w C-PTSD. Stephen Porges (2011, teoria poliwalgalna): *brzuszna gałąź nerwu błędnego* = bezpieczeństwo społeczne. Techniki regulacji wagalnej: oddech przeponowy z przedłużonym wydechem (4 sek wdech, 8 sek wydech), mrużenie/śpiew (wibracja strun głosowych aktywuje n. X), zimna woda na twarz (odruch nurkowy — natychmiastowa aktywacja parasympatyka), powolny ruch (joga, tai chi, qi gong). Dotyk bezpieczny: *butterfly hug* (Artigas, 2000), self-holding, koc obciążeniowy (*deep touch pressure*, aktywuje parasympatyk, Grandin, 1992). **Kluczowe:** regulacja somatyczna jest *fundamentem* Fazy 1 — zanim mózg może przetwarzać, ciało musi czuć się *bezpiecznie* (Ogden, 2006).

01



Cztery techniki regulacji brzusznej gałęzi nerwu błędnego

A · ODDECH 4-7-8

Wdech 4 s — wstrzymanie 7 s — wydech 8 s. 4 cykle. Wydłużony wydech aktywuje gałąź brzuszną nerwu błędnego, obniża tętno i kortyzol. *Najszybsza i najtańsza interwencja.*

B · „VOO”-NUCENIE (PORGES)

Długie „voooo” przez 30–60 sek, niski ton, na każdym wydechu. Wibracja strun głosowych stymuluje n. X. Można cicho, w samochodzie, łożenie. Działa nawet bez muzykalności.

C · KONTAKT FIZYCZNY

Ręka na sercu lub na brzuchu. Ciepło, lekka presja. *Butterfly hug* (skrzyżowane ręce na klatce, naprzemienne stuknięcia). Koc obciążeniowy. *Deep touch pressure* (Grandin, 1992) aktywuje parasympatyk.

D · ORIENTACJA (LEVINE)

Powolne rozglądanie się. Bez pośpiechu, oczami i głową. Pytanie: „czy tu jest bezpiecznie?”. 30–60 sek. Mózg sprawdza otoczenie i wraca z odpowiedzią: „tak, teraz”.

02 ? Dlaczego ciało jest „wejściem” do regulacji

W wysokiej aktywacji kora przedczołowa *nie* ma pełnego dostępu — to nie „brak woli” ani „lenistwo”, to neurologia (Lanius i in., 2010). Werbalna instrukcja „*uspokój się*” nie dociera. Działa natomiast bodziec somatyczny: oddech wagotoniczny, wibracja głosowa, dotyk, zimna woda — wszystkie aktywują *gałąź brzuszna nerwu błędnego* (Porges, 2011) z *dołu do góry*. Sygnał: „*jestem bezpieczny/-a*” idzie z ciała do mózgu, nie z mózgu do ciała.

Van der Kolk (2014, RCT, N = 64): *trauma-sensitive yoga* przez 10 tygodni — istotna redukcja C-PTSD ($d = 0,57$). To *jedyny* RCT jogi w C-PTSD. Inne formy ruchu (tai chi, qi gong, taniec terapeutyczny, spacer z uważnością) działają podobnie, choć z mniejszą bazą badań.

03 ✎ Mój zestaw narzędzi + plan praktyki

MOJA TECHNIKA PIERWSZEGO WYBORU

— która z czterech (oddech / głos / dotyk / orientacja) działa u mnie najszybciej; gdzie się sprawdza

TECHNIKA ZAPASOWA

— gdy pierwsza nie działa lub kontekst nie pozwala (w pracy, komunikacji miejskiej, przy ludziach)

MÓJ PLAN CODZIENNEJ PRAKTYKI

— jedna technika 10–15 min dziennie poza kryzysem (np. rano, wieczorem); trening, by była dostępna w kryzysie

FORMA RUCHU, KTÓRĄ WPROWADZĘ

— joga, tai chi, qi gong, spacer z uważnością; 2–3 razy w tygodniu; zacznij od krótkich sesji

Klucz: regulacja somatyczna *nie* jest „luksusem” ani „mile widzianym dodatkiem” — jest **fundamentem** Fazy 1 w C-PTSD. Van der Kolk (2014): „*ciało przechowuje wynik*” — chroniczna trauma żyje w napięciu mięśniowym, oddechu, postawie, sposobie reagowania. Sama terapia werbalna często nie sięga do tego poziomu. Ogden i in. (2006): praca z ciałem *w oknie tolerancji* dopełnia pracę poznawczą — bez niej terapia może być intelektualnie satysfakcjonująca, ale ciało nadal jest w trybie alarmu. Trening codzienny *poza* kryzysem buduje ścieżki neuronalne dostępne w kryzysie. To kwestia tygodni i miesięcy, nie dni. Konsekwencja jest ważniejsza niż czas trwania pojedynczej sesji — 5 min codziennie przeważa nad 30 min raz w tygodniu.

△ U niektórych pacjentów dotyk lub silne bodźce somatyczne mogą być wyzwalaczem — wtedy techniki bezdotykowe (głos, oddech, orientacja) są pierwszym wyborem. Joga trauma-sensitive różni się od „zwykłej” jogi — brak korekt fizycznych, brak intensywnego oddechu (np. pranayama), pełna kontrola pacjenta nad każdą pozą. Zwykła joga (zwłaszcza dynamiczna lub z dotykiem instruktora) może destabilizować — warto poszukać instruktora przeszkolonego w pracy z traumą.